BONUS 3

Opis prema kliničkom pitanju: 30 kliničkih pitanja

Kakvo god pitanje bilo napisano na uputnici, prva rečenica Vašeg opisa mora na njega odgovoriti. Za 30 najčešćih kliničkih pitanja: na što opis obvezno mora odgovoriti, negativna rečenica i pozitivna rečenica.

Sadržaj

Zašto kliničko pitanje dolazi prvo

Neuroradiologija — 5 pitanja

Prsni koš — 7 pitanja

Abdomen i zdjelica — 10 pitanja

Vaskularno — 3 pitanja

Mišićno-koštani sustav i kralježnica — 5 pitanja

Sljedeći korak

NA POČETKU

Zašto kliničko pitanje dolazi prvo

U koraku PRIPREMITE čitate uputnicu; u koraku SAŽMITE odgovarate na nju.

> *Kad liječnik koji je napisao uputnicu otvori opis, traži samo jedno: odgovor na svoje pitanje. Ako ga ne nađe, nazvat će ili će pogrešno protumačiti opis.*

1. **Pročitajte uputnicu i svedite pitanje na jednu riječ** — «apendicitis?», «krvarenje?», «kamenac?».
2. **Pregled ipak obavite u cijelosti** — pitanje daje fokus, ali ostale regije ne preskačemo.
3. **Popis «obvezno» iz pitanja pokrijte u Nalazima** — svaka se stavka piše ili kao pozitivan ili kao važan negativan nalaz.
4. **Prva rečenica Zaključka odgovor je na pitanje** — ako je pozitivno, nalaz i po potrebi obavijest; ako je negativno, jasna negativna rečenica.
5. **Navedite ograničenja** — ako pretraga nije dostatna da isključi ono što se pita, to jasno navedite.

Ako je uputnica nejasna

Kod nejasnih uputnica poput «kontrola» ili «bol» pokušajte doznati kliničke podatke iz dokumentacije ili od liječnika koji je napisao uputnicu. Ako ih ne doznate, strukturirajte opis prema najvjerojatnijem pitanju i odgovorite na česte uzroke jedan po jedan.

POGLAVLJE 1

Neuroradiologija

5 kliničkih pitanja

01 «Moždani udar?»

Često korištena pretraga: Nativni CT mozga ± CT angiografija; MR-DWI

OPIS OBVEZNO MORA ODGOVORITI

- Postoji li krvarenje ili ne (prva rečenica)
- Rani znakovi ishemije i područje opskrbe
- Znak hiperdenzne arterije
- Ako je učinjena CT angiografija, okluzija velike krvne žile
- Vrijeme obavijesti

NEGATIVNA REČENICA

Intrakranijalno krvarenje nije utvrđeno. Rane ishemijske promjene nisu prikazane; rani ishemijski moždani udar možda se neće vidjeti na nativnom CT-u.

POZITIVNA REČENICA

Bez intrakranijalnog krvarenja; [desno/lijevo] Rani znakovi akutne ishemije u području opskrbe MCA. U okviru protokola za moždani udar [vrijeme]: priopćeno.

02 «Trauma glave — krvarenje?»

Često korištena pretraga: Nativni CT mozga (moždani i koštani prozor)

OPIS OBVEZNO MORA ODGOVORITI

- Ekstraaksijalno i parenhimsko krvarenje
- Učinak mase i pomak središnje linije (mm)
- Bazalne cisterne
- Prijelom kalvarije i baze lubanje
- Pneumocefalus

NEGATIVNA REČENICA

Akutno intrakranijalno krvarenje, učinak mase ni prijelom kalvarije nisu utvrđeni.

POZITIVNA REČENICA

[Desno/Lijevo] akutni [epiduralni/subduralni] hematom; [.. mm] pomak središnje linije. [Vrijeme]: priopćeno.

03 «Nagla jaka glavobolja — SAH?»

Često korištena pretraga: Nativni CT mozga ± CT angiografija

OPIS OBVEZNO MORA ODGOVORITI

- Subarahnoidalno krvarenje i njegova raspodjela
- Hidrocefalus
- Intraventrikularno ili parenhimsko krvarenje
- Preporuka CTA zbog aneurizme

NEGATIVNA REČENICA

Subarahnoidalno krvarenje nije utvrđeno. Osjetljivost CT-a smanjuje se s vremenom proteklim od početka; ako klinička sumnja i dalje postoji, daljnja procjena prepušta se kliničkoj odluci.

POZITIVNA REČENICA

[U bazalnim cisternama] subarahnoidalno krvarenje; hidrocefalus [nema/ima]. Preporučuje se CT angiografija. [Vrijeme]: priopćeno.

04 «Masa?»

Često korištena pretraga: MR mozga s kontrastom (ako postoji sumnja na CT-u)

OPIS OBVEZNO MORA ODGOVORITI

- Broj, mjesto i veličina lezija
- Razlikovanje intra/ekstraaksijalno
- Edem i učinak mase
- Hernijacija
- Najvjerojatnija diferencijalna dijagnoza

NEGATIVNA REČENICA

Na MR-u mozga s kontrastom nisu utvrđene ekspanzivna lezija ni patološka imbibicija kontrastom.

POZITIVNA REČENICA

[Desno/Lijevo] [režanj]: [.. mm] [intraaksijalni/ekstraaksijalni] masa; [diferencijalna dijagnoza]. Znakovi hernijacije [nema/ima].

05 «Hidrocefalus / disfunkcija shunta?»

Često korištena pretraga: Nativni CT mozga; usporedba s prethodnom pretragom

OPIS OBVEZNO MORA ODGOVORITI

- Promjena veličine ventrikula u usporedbi s prethodnom pretragom
- Periventrikularni edem
- Položaj vrha katetera shunta
- Krvarenje

NEGATIVNA REČENICA

U usporedbi s prethodnom pretragom nema promjene veličine ventrikula; vrh katetera shunta [položaj].

POZITIVNA REČENICA

U usporedbi s prethodnom pretragom izraženo proširenje ventrikula; može govoriti u prilog disfunkcije shunta. [Vrijeme]: priopćeno.

POGLAVLJE 2

Prsni koš

7 kliničkih pitanja

06 «Pneumotoraks?»

Često korištena pretraga: RTG prsnog koša; po potrebi CT ili POCUS

OPIS OBVEZNO MORA ODGOVORITI

- Postoji li pneumotoraks, strana
- Mjera ili količina
- Znakovi tenzijskog pneumotoraksa
- Pridruženi prijelom rebra, potkožni emfizem

NEGATIVNA REČENICA
Pneumotoraks nije utvrđen.

POZITIVNA REČENICA
[Desno/Lijevo] pneumotoraks, apikalno [.. mm]; znakovi tenzije [nema/ima]. [Vrijeme]: priopćeno.

07 «Pneumonija?»

Često korištena pretraga: RTG prsnog koša; po potrebi CT prsnog koša

OPIS OBVEZNO MORA ODGOVORITI

- Postoji li konsolidacija, režanj/segment
- Pleuralni izljev
- Kavitacija ili apsces
- Promjena u usporedbi s prethodnom pretragom

NEGATIVNA REČENICA
U plućnom parenhimu nije utvrđena konsolidacija koja bi govorila u prilog pneumoniji.

POZITIVNA REČENICA
[Desno/Lijevo] [režanj] konsolidacija; uz klinički nalaz može odgovarati pneumoniji. Pleuralni izljev [nema/ima].

08 «Plućna embolija?»

Često korištena pretraga: CT plućna angiografija

OPIS OBVEZNO MORA ODGOVORITI

- Dostatnost opacifikacije
- Postoji li embolija i najproksimalnija razina
- Opterećenje desne klijetke
- Alternativna dijagnoza (pneumonija, izljev)

NEGATIVNA REČENICA
Opacifikacija plućne arterije je dostatna; plućna tromboembolija nije utvrđena.

POZITIVNA REČENICA
[Obostrano] [lobarno/segmentno] akutna plućna tromboembolija; opterećenje desne klijetke [nema/ima]. [Vrijeme]: priopćeno.

09 «Disekcija aorte?»

Često korištena pretraga: CT angiografija (nativno + arterijska faza)

OPIS OBVEZNO MORA ODGOVORITI

- Postoji li disekcija
- Zahvaćenost uzlazne aorte
- Zahvaćenost ogranaka i perfuzija organa
- Perikardijalni izljev, medijastinalni hematom
- Intramuralni hematom

NEGATIVNA REČENICA
Disekcija aorte, intramuralni hematom ni penetrirajući ulkus nisu utvrđeni.

POZITIVNA REČENICA
[Stanford A/B] disekcija aorte; [zahvaćenost ogranaka]. Hitni nalaz; [vrijeme]: priopćeno.

10 «Položaj cijevi / katetera?»

Često korištena pretraga: AP snimka prsnog koša uz krevet

OPIS OBVEZNO MORA ODGOVORITI

- Gdje je vrh svakog uređaja
- Udaljenost ETT-a od karine
- Je li NG sonda u želucu
- Pneumotoraks vezan uz zahvat

NEGATIVNA REČENICA
Vrh ETT-a od karine [.. cm] iznad nje; vrh NG sonde u projekciji želuca, vrh CVK-a u projekciji gornje šuplje vene; bez pneumotoraksa.

POZITIVNA REČENICA
[Vrh NG sonde u projekciji desnog glavnog bronha], nije u odgovarajućem položaju. Prije uporabe [vrijeme]: priopćeno.

11 «Zatajenje srca / plućni edem?»

Često korištena pretraga: RTG prsnog koša; UZV pluća

OPIS OBVEZNO MORA ODGOVORITI

- Veličina srca (uz navođenje projekcije)
- Vaskularna kongestija i intersticijski edem
- Pleuralni izljev
- Promjena u usporedbi s prethodnom pretragom

NEGATIVNA REČENICA
Znakovi plućnog edema ni pleuralnog izljeva nisu utvrđeni.

POZITIVNA REČENICA
Nalaz govori u prilog plućnog edema uz obostrani mali pleuralni izljev; u usporedbi s prethodnom pretragom [porast/regresija].

12 «Pleuralni izljev?»

Često korištena pretraga: RTG prsnog koša; UZV prsnog koša

OPIS OBVEZNO MORA ODGOVORITI

- Postoji li izljev, strana
- Količina
- Sadržaj (UZV: anehogen, sa septama, ehogen)
- Podležeća patologija parenhima
- Odgovarajući prozor za zahvat (ako se traži)

NEGATIVNA REČENICA
Pleuralni izljev nije utvrđen.

POZITIVNA REČENICA
[Desno/Lijevo] [mala/umjerena/velika] količina [anehogen/kompliciranog izgleda] pleuralni izljev.

POGLAVLJE 3

Abdomen i zdjelica

10 kliničkih pitanja

13 «Apendicitis?»

Često korištena pretraga: Dijete/mlada osoba/trudnica: UZV; odrasla osoba: CT s kontrastom

OPIS OBVEZNO MORA ODGOVORITI

- Je li apendiks prikazan
- Promjer, stijenka, okolno masno tkivo
- Apendikolit
- Perforacija, apsces
- Ako nije prikazan, da to ne isključuje apendicitis

NEGATIVNA REČENICA
Apendiks je normalnog izgleda; znakovi akutnog apendicitisa nisu utvrđeni.

POZITIVNA REČENICA
Nalaz odgovara akutnom apendicitisu; perforacija ili apsces [nema/ima]. [Vrijeme]: priopćeno.

14 «Kamenac? (bubrežna kolika)»

Često korištena pretraga: Nativni CT (protokol za kamence); UZV

OPIS OBVEZNO MORA ODGOVORITI

- Postoji li kamenac, mjesto i veličina (mm)
- Stupanj hidronefroze
- Kontralateralni bubreg
- Alternativna dijagnoza

NEGATIVNA REČENICA
U mokraćnom sustavu nisu utvrđeni kamenci ni hidronefroza.

POZITIVNA REČENICA
[Desno/Lijevo] [distalno] u ureteru [.. mm] kamenac i [blaga] hidroureteronefroza.

15 «Kolecistitis?»

Često korištena pretraga: UZV abdomena

OPIS OBVEZNO MORA ODGOVORITI

- Kamenac
- Debljina stijenke i perikolecistična tekućina
- Sonografski Murphyjev znak
- Promjer koledokusa
- Komplikacija (gangrena, perforacija)

NEGATIVNA REČENICA
Žučnjak uredan; kamenci ni znakovi akutnog kolecistitisa nisu utvrđeni. Koledokus [.. mm].

POZITIVNA REČENICA
Nalaz odgovara akutnom kalkuloznom kolecistitisu; koledokus [.. mm]. [Vrijeme]: priopćeno.

16 «Opstrukcija / ileus?»

Često korištena pretraga: Nativna snimka abdomena u stojećem položaju; CT abdomena s kontrastom

OPIS OBVEZNO MORA ODGOVORITI

- Postoji li opstrukcija, tanko/debelo crijevo
- Prijelazna zona i mogući uzrok
- Znakovi strangulacije/ishemije
- Slobodni zrak

NEGATIVNA REČENICA
Znakovi mehaničke opstrukcije crijeva nisu utvrđeni.

POZITIVNA REČENICA
[Regija]: mehanička opstrukcija tankog crijeva s prijelaznom zonom; znakovi ishemije [nema/ima].

17 «Perforacija / slobodni zrak?»

Često korištena pretraga: RTG prsnog koša u stojećem položaju; CT abdomena

OPIS OBVEZNO MORA ODGOVORITI

- Postoji li slobodni zrak
- Moguće mjesto perforacije
- Slobodna tekućina, apsces
- Nedavni kirurški zahvat u anamnezi

NEGATIVNA REČENICA
Slobodni zrak nije utvrđen.

POZITIVNA REČENICA
Pneumoperitoneum; [moguća lokalizacija] u prilog perforacije. [Vrijeme]: priopćeno.

18 «Pankreatitis / komplikacija?»

Često korištena pretraga: CT abdomena s kontrastom (obično nakon nekog vremena od početka)

OPIS OBVEZNO MORA ODGOVORITI

- Tip pankreatitisa (edematozni/nekrotizirajući)
- Peripankreatična tekućina ili kolekcija
- Vaskularna komplikacija
- Žučni kamenac

NEGATIVNA REČENICA
Znakovi akutnog pankreatitisa nisu utvrđeni.

POZITIVNA REČENICA
Akutno [nekrotizirajući] pankreatitis; [kolekcija/vaskularna komplikacija] [nema/ima].

19 «Trauma — ozljeda solidnog organa?»

Često korištena pretraga: CT s kontrastom kod traume; FAST

OPIS OBVEZNO MORA ODGOVORITI

- Svaki solidni organ zasebno
- Hemoperitoneum i njegova količina
- Aktivna ekstravazacija
- Ozljeda crijeva/mezenterija
- Koštane ozljede

NEGATIVNA REČENICA
Znakovi ozljede solidnih organa, slobodne tekućine ni aktivnog krvarenja nisu utvrđeni.

POZITIVNA REČENICA
[Organ] ozljeda i hemoperitoneum; aktivna ekstravazacija [nema/ima]. [Vrijeme]: priopćeno.

20 «Izvanmaternična trudnoća?»

Često korištena pretraga: Transvaginalni i transabdominalni UZV zdjelice

OPIS OBVEZNO MORA ODGOVORITI

- Postoji li intrauterina trudnoća
- Adneksalna masa
- Slobodna tekućina i njezin sadržaj
- Stanje jajnika

NEGATIVNA REČENICA
U materištu [sa žumanjčanom vrećom] prikazana je gestacijska vreća; adneksalna masa ni slobodna tekućina nisu utvrđene.

POZITIVNA REČENICA
Intrauterina trudnoća nije prikazana; [desno/lijevo] nalazi u prilog ektopičnoj trudnoći s adneksalnom masom i slobodnom tekućinom. [Vrijeme]: priopćeno.

21 «Divertikulitis?»

Često korištena pretraga: CT abdomena i zdjelice s kontrastom

OPIS OBVEZNO MORA ODGOVORITI

- Zahvaćeni segment
- Je li kompliciran (apsces, perforacija, fistula)
- Veličina apscesa
- Alternativna dijagnoza

NEGATIVNA REČENICA
Znakovi divertikulitisa nisu utvrđeni.

POZITIVNA REČENICA
[Sigmoidni kolon] u kolonu akutni [komplicirani/nekomplicirani] divertikulitis; apsces [ne postoji/postoji, .. mm].

22 «Bol u trbuhu — uzrok?»

Često korištena pretraga: CT abdomena i zdjelice s kontrastom ili UZV

OPIS OBVEZNO MORA ODGOVORITI

- Postoji li akutna kirurška patologija
- Česti uzroci jedan po jedan: apendiks, žučnjak, crijevo, mokraćni sustav
- Slobodna tekućina i slobodni zrak
- Vaskularna patologija (aorta)

NEGATIVNA REČENICA
Nije utvrđena akutna patologija koja bi objasnila bol u trbuhu.

POZITIVNA REČENICA
[Nalaz]; može objasniti bol u trbuhu. [Po potrebi obavijest].

POGLAVLJE 4

Vaskularno

3 klinička pitanja

23 «DVT?»

Često korištena pretraga: Venski dopplerski UZV donjih ekstremiteta

OPIS OBVEZNO MORA ODGOVORITI

- Koji su segmenti procijenjeni
- Kompresibilnost
- Proksimalna granica tromba
- Jesu li procijenjene vene potkoljenice

NEGATIVNA REČENICA

[Desno/Lijevo] u dubokim venama donjih ekstremiteta [u procijenjenim segmentima] tromboza nije utvrđena.

POZITIVNA REČENICA

[Desno/Lijevo] [femoropoplitealna] segment: akutna DVT; proksimalna granica [razina]. [Vrijeme]: priopćeno.

24 «Torzija testisa?»

Često korištena pretraga: UZV skrotuma u sivoj skali i obojeni Doppler

OPIS OBVEZNO MORA ODGOVORITI

- Intratestikularni protok (u usporedbi s drugom stranom)
- Veličina i ehostruktura testisa
- Sjemenski snop
- Alternativna dijagnoza (epididimitis)

NEGATIVNA REČENICA

Testikularni protok obostrano je simetričan; znakovi torzije nisu utvrđeni. Prisutnost protoka ne isključuje u potpunosti intermitentnu torziju.

POZITIVNA REČENICA

[Desno/Lijevo] u testisu protok nije prikazan; odgovara torziji. Hitni nalaz; [vrijeme]: priopćeno.

25 «AAA / ruptura?»

Često korištena pretraga: UZV abdominalne aorte; CT angiografija

OPIS OBVEZNO MORA ODGOVORITI

- Najveći promjer (mm)
- Odnos prema renalnim arterijama
- Periaortalni hematom (ruptura)
- Ograničenje UZV-a kod simptomatskog bolesnika

NEGATIVNA REČENICA

Abdominalna aorta normalnog promjera; aneurizma nije utvrđena.

POZITIVNA REČENICA

Infrarenalna AAA, najveći promjer [.. mm]; znakovi rupture [nema/ima]. [Vrijeme]: priopćeno.

POGLAVLJE 5

Mišićno-koštani sustav i kralježnica

5 kliničkih pitanja

26 «Prijelom?»

Često korištena pretraga: RTG snimka (najmanje dvije projekcije); po potrebi CT/MR

OPIS OBVEZNO MORA ODGOVORITI

- Postoji li prijelom, kost i razina
- Intraartikularno širenje
- Pomak, angulacija
- Iščašenje
- Ako je RTG negativan, mogućnost okultnog prijeloma

NEGATIVNA REČENICA

Akutni prijelom ili iščašenje nisu utvrđeni. Ako klinička sumnja i dalje postoji, okultni prijelom ne može se isključiti rendgenskom snimkom.

POZITIVNA REČENICA

[Desno/Lijevo] [kost] [lokalizacija] prijelom; [intraartikularni/ekstraartikularni], [pomak].

27 «Prijelom kuka? (starija osoba, pad)»

Često korištena pretraga: AP snimka zdjelice + lateralna snimka kuka; ako je negativno, MR ili CT

OPIS OBVEZNO MORA ODGOVORITI

- Vrat femura i intertrohanterna regija
- Pomak
- Zdjelični prsten i pubične grane
- Preporuka daljnje obrade zbog okultnog prijeloma

NEGATIVNA REČENICA

U kuku i zdjelici nije utvrđen akutni prijelom. Ako je klinička sumnja visoka, radi okultnog prijeloma preporučuje se MR ili CT.

POZITIVNA REČENICA

[Desno/Lijevo] prijelom vrata femura ([s pomakom/bez pomaka]).

28 «Kompresija moždine / cauda equina?»

Često korištena pretraga: MR cijele kralježnice ili lumbalni MR

OPIS OBVEZNO MORA ODGOVORITI

- Postoji li kompresija, razina i uzrok
- Promjena signala moždine
- Korijeni caude equine
- Dodatne razine

NEGATIVNA REČENICA
Kompresija kralježnične moždine ni caude equine nije utvrđena.

POZITIVNA REČENICA
[Razina] na toj razini [uzrok] uz kompresiju kralježnične moždine. Hitni nalaz; [vrijeme]: priopćeno.

29 «Trauma vratne kralježnice — prijelom?»

Često korištena pretraga: CT vratne kralježnice

OPIS OBVEZNO MORA ODGOVORITI

- Poravnanje
- Znakovi prijeloma i nestabilnosti
- Kraniocervikalni prijelaz
- Prevertebralno meko tkivo
- Potreba za MR-om zbog ligamentarne ozljede

NEGATIVNA REČENICA
U vratnoj kralježnici nisu utvrđeni akutni prijelom ni poremećaj poravnanja.

POZITIVNA REČENICA
[Razina] na toj razini [prijelom/iščašenje]; s obzirom na nestabilnost [vrijeme]: priopćeno.

30 «Septički artritis / osteomijelitis?»

Često korištena pretraga: RTG snimka; UZV (izljev); MR

OPIS OBVEZNO MORA ODGOVORITI

- Zglobni izljev
- Zahvaćenost koštane srži
- Apsces mekih tkiva
- Ograničenja slikovne dijagnostike (potreba za aspiracijom klinička je odluka)

NEGATIVNA REČENICA
[Zglob]: izljev nije utvrđen; promjene koštane srži u prilog osteomijelitisa nisu prikazane.

POZITIVNA REČENICA
[Zglob]: izljev i [edem koštane srži/apsces]; radi septičkog artritisa/osteomijelitisa preporučuje se hitna klinička procjena. [Vrijeme]: priopćeno.

U edukativne svrhe. Ovaj materijal ne zamjenjuje specijalizaciju, nadzor mentora, kliničku prosudbu ni nalaz specijalista.

Sljedeći korak

Sada otvorite Brzi bonus · Kontrolni popis opisa na jednoj stranici. Odgovor na kliničko pitanje, strana, mjera, usporedba i obavijest: provjerite u jednoj minuti prije potpisa.

Za cjelovite obrasce opisa **Glavni materijal · 120 predložaka gotovih opisa** se možete vratiti.